

Atividade em Grupo — Matriz MoSCoW

Continuação do Estudo de Caso — Sistema de Atendimento e Agendamento (Clínica Vida+ Saúde)

Disciplina: Engenharia de Requisitos

Guia Prático: MoSCoW

Integrante: Sara Rebeca do Rosario Soares

11. Atividade do Grupo — Matriz MoSCoW

Técnica aplicada aos requisitos levantados no projeto. Apenas uma categoria foi marcada por requisito, com a respectiva justificativa.

ID	Requisito	M	S	C	W	Justificativa
RF01	Cadastrar pacientes.	X				Pré-requisito para qualquer agendamento (RN01); sem cadastro, nenhuma outra funcionalidade pode ser executada.
RF02	Consultar pacientes cadastrados.		X			Importante para o atendimento e o histórico, mas o sistema pode operar de forma mínima sem consulta avançada na primeira versão.
RF03	Cadastrar médicos.	X				Sem médicos cadastrados não há agenda para oferecer ao paciente.
RF04	Cadastrar especialidades.		X			Ajuda a organizar a busca, mas o agendamento pode inicialmente ser feito apenas por médico, sem filtro de especialidade.
RF05	Consultar horários disponíveis por médico.	X				Essencial para que o paciente saiba quando pode ser atendido; sem isso não há como agendar.
RF06	Realizar agendamentos de consultas.	X				É o núcleo do processo de negócio; sem ele o sistema não cumpre seu propósito.
RF07	Cancelar agendamentos.	X				Necessário para liberar horários e evitar ociosidade da agenda (RN04).
RF08	Reagendar consultas.			X		É uma conveniência; enquanto não existir, pode ser feito manualmente (cancelar e criar um novo agendamento).
RQ01	Desempenho — resposta em até 3 segundos ao consultar horários.		X			Melhora a experiência do usuário, mas o sistema continua funcional mesmo com resposta um pouco mais lenta no início.
RQ02	Segurança — acesso aos dados dos pacientes restrito a usuários autenticados.	X				Proteção de dados sensíveis de saúde é inegociável, inclusive por exigência legal.

ID	Requisito	M	S	C	W	Justificativa
RQ03	Disponibilidade — sistema disponível 99% do tempo em horário comercial.		X			Importante para a confiabilidade, mas indisponibilidades pontuais não inviabilizam o uso na primeira versão.
RQ04	Privacidade — conformidade com a LGPD no tratamento dos dados dos pacientes.	X				Obrigaç�o legal para o tratamento de dados de sa�de; sem isso o sistema n�o pode operar.
RQ05	Usabilidade — acesso responsivo via web e dispositivo m�vel.			X		Melhora a experi�ncia, mas o acesso por um �nico canal (ex.: web) j� viabiliza o uso inicial.

12. Definindo a Primeira Vers o

Situa  o-problema: a equipe descobriu que ter  apenas metade do tempo inicialmente previsto para desenvolver a primeira vers o.

Parte A — 5 requisitos indispens veis

Ordem	ID	Requisito	Por que precisa permanecer?
1	RF06	Realizar agendamentos de consultas.	� o n�cleo do processo de neg�cio; entrega o valor central ao paciente e � cl�nica.
2	RF01	Cadastrar pacientes.	Pr�-requisito obrigat�rio para que qualquer agendamento exista.
3	RF05	Consultar hor�rios dispon�veis.	Sem verificar disponibilidade, n�o � poss�vel agendar sem conflito.
4	RQ04	Privacidade — conformidade com a LGPD.	Obriga�o legal no tratamento de dados de sa�de; sem ela o sistema n�o pode operar.
5	RF07	Cancelar agendamentos.	Evita agenda travada e permite liberar hor�rios para outros pacientes (RN04).

Parte B — 3 requisitos que podem ir para uma vers o futura

ID	Requisito	Impacto de adiar
RF08	Reagendar consultas.	O paciente precisa cancelar e criar um novo agendamento manualmente; mais lento, mas vi�vel.
RQ01	Desempenho — resposta em at� 3 segundos.	O sistema responde um pouco mais devagar, mas continua funcional para o uso inicial.
RQ05	Usabilidade — acesso responsivo web/mobile.	O uso fica restrito a um �nico canal (web) at� a vers�o m�vel/responsiva ser desenvolvida.

13. Desafio — Definindo o MVP

Observando os requisitos classificados como Must Have (RF01, RF03, RF05, RF06, RF07, RQ02 e RQ04):

Sim. Com esse conjunto de requisitos o grupo consegue entregar uma primeira versão que resolve o problema principal do usuário: agendar e realizar consultas sem conflito de horário, com segurança e conformidade legal no tratamento dos dados do paciente.

Funcionalidades de conveniência — como reagendamento, filtro por especialidade e otimizações de desempenho/usabilidade — ficam para versões seguintes, sem comprometer a entrega do valor essencial ao usuário.

14. Checklist MoSCoW

- [X] Todos os requisitos possuem uma prioridade?
- [X] Cada requisito possui apenas uma classificação?
- [X] Os Must são realmente indispensáveis?
- [X] Existe justificativa para cada prioridade?
- [X] O grupo considerou valor para o negócio e necessidades dos stakeholders?
- [X] Foram analisadas dependências, riscos e obrigações?
- [X] Requisitos de qualidade também foram priorizados?
- [X] Existem requisitos classificados como Could ou Won't?
- [X] A equipe consegue explicar o impacto de retirar cada Must?
- [X] A primeira versão é viável considerando as restrições do projeto?

15. Reflexão do Grupo

1. RF08 (reagendar consultas) foi o requisito mais difícil de priorizar, pois melhora bastante a experiência do paciente, mas não é indispensável para o funcionamento básico do sistema.
2. Sim: RF04 (cadastro de especialidades) inicialmente parecia essencial, mas foi rebaixado para Should Have ao perceber que o agendamento pode ocorrer diretamente por médico, sem filtro de especialidade na primeira versão.
3. RQ01 (desempenho) gerou a maior divergência, pois trata de qualidade percebida pelo usuário — importante, mas não impede o funcionamento do sistema caso a resposta seja um pouco mais lenta.
4. Se todos os requisitos fossem classificados como Must, a equipe perderia a capacidade de negociar prazos e recursos, e o projeto correria o risco de não ser entregue dentro do tempo reduzido disponível.
5. A primeira versão seria formada por: RF01, RF03, RF05, RF06, RF07, RQ02 e RQ04.